

CUIDA

Plataforma de coordinación de ayuda y cuidados a domicilio

Masterplan empresarial, funcional y técnico

De una infraestructura de identificación y gestiones a una plataforma capaz de transformar una necesidad humana en un servicio organizado, asignado, realizado, seguido y cerrado.

Caso fundador: Herminia necesita ayuda para hacer la compra y compañía durante varios días porque su familia estará fuera.

Documento de trabajo — septiembre de 2026

1. Resumen ejecutivo

CUIDA no debe plantearse como otra agenda de cuidadores. Su propuesta es gestionar necesidades concretas de ayuda: una persona solicita lo que necesita, CUIDA estructura la necesidad, busca o recibe la oferta adecuada, organiza el servicio, registra su ejecución y permite el seguimiento a la persona y a sus familiares autorizados.

La infraestructura heredada de IDENTIA resulta útil porque ya contiene personas, identificadores permanentes, datos, gestiones, estados, documentos, usuarios, roles, historial y auditoría. CUIDA añade la capa que faltaba: necesidad → solicitud → servicio → asignación → visita → actuación → seguimiento → cierre.

El proyecto debe comenzar como prototipo conceptual/portfolio y no como servicio real. Si posteriormente se convierte en producto, habrá que validar jurídicamente el modelo de prestación/intermediación, protección de datos, contratación y responsabilidades.

En 2026 el Ministerio de Derechos Sociales ha impulsado una ampliación de los cuidados a domicilio y de la asistencia personal, incluyendo acompañamiento en actividades como acudir al médico o hacer la compra.

Objetivo: demostrar un sistema operativo de cuidados que conecte persona, familia, profesional y organización sin convertir CUIDA en una historia clínica ni en una plataforma médica.

2. Visión y posicionamiento

Visión: hacer que pedir ayuda para una persona sea tan sencillo como explicar qué necesita, cuándo y dónde; y que detrás exista un sistema capaz de convertir esa petición en una atención organizada y trazable.

Propuesta de valor: “CUIDA convierte necesidades de cuidado en servicios coordinados.”

Principio UX: la persona no debería tener que conocer el nombre técnico del servicio que necesita.

En lugar de obligar a elegir categorías administrativas, CUIDA parte de lenguaje humano: “Necesito que alguien acompañe a mi madre”, “necesito ayuda con la compra”, “necesito compañía durante una semana” o “necesito acompañar a mi padre al médico”.

La plataforma traduce esa petición a datos estructurados, propone un servicio y solicita confirmación antes de ejecutarlo.

No es objetivo inicial diagnosticar, prescribir, sustituir a profesionales sanitarios, crear una historia clínica completa ni decidir autónomamente qué atención médica requiere una persona.

3. Caso de uso fundador: Herminia

Situación: Herminia vive en su domicilio. Sus familiares se ausentan durante varios días. No necesita necesariamente atención sanitaria: necesita apoyo cotidiano, compañía y ayuda con la compra.

Entrada: “Necesito que alguien venga de lunes a viernes por las mañanas durante 10 días. Necesito compañía y que me ayude con la compra y la comida.”

Etapas	Sistema	Resultado
1. Necesidad	Lenguaje natural / formulario	Necesidad entendida
2. Solicitud	CUI-SOL-000582	Petición trazable
3. Plan	Fechas + horas + tareas	Servicio definido
4. Asignación	Proveedor/profesional	Responsable asignado
5. Confirmación	Persona/familia/proveedor	Servicio aceptado
6. Ejecución	Inicio + tareas + observaciones	Visita registrada
7. Seguimiento	Estado + incidencias	Situación visible
8. Cierre	Fin + validación	Servicio cerrado

Principio: la persona pide ayuda; el sistema se encarga de traducirla a una estructura operativa.

4. Actores y permisos

Actor	Necesidad	Acceso
Persona atendida	Solicitar y recibir ayuda	Datos, solicitudes y servicios propios
Familiar autorizado	Gestionar/seguir ayuda	Según autorización
Profesional/cuidador	Realizar servicios	Servicios y datos necesarios
Coordinador	Asignar y supervisar	Personas/servicios de su organización
Organización	Gestionar operaciones	Ámbito de la organización
Administrador	Configurar sistema	Configuración y auditoría
Superadmin	Gobierno SaaS	Multitenant, soporte y seguridad

Los permisos deben diseñarse desde el principio. La AEPD establece que el acceso a información personal debe estar justificado y limitado a lo necesario; en ámbitos sanitarios, ser profesional no da acceso por sí mismo a información confidencial. [\[cite\]turn0search4](#)

5. Modelo de datos

La arquitectura debe separar identidad, necesidad y ejecución. Una modificación administrativa no debe destruir el historial.

Entidad	Función	Ejemplo
Persona	Identidad permanente	CUI-000184
Familiar/relación	Relación autorizada	Hija — representante
Profesional	Quien presta servicio	PRO-00031
Organización	Proveedor/empresa	ORG-00017
Necesidad	Qué necesita	Compra + compañía
Solicitud	Petición concreta	SOL-000582
Plan	Conjunto temporal	3-12 octubre
Servicio	Unidad asignada	SRV-000721
Visita	Ejecución concreta	VIS-001923
Tarea	Actividad prevista	Realizar compra
Actuación	Lo ocurrido	Compra realizada
Incidencia	Situación a revisar	Retraso
Documento	Archivo asociado	Parte
Gestión	Proceso administrativo	Cambio horario
Pago	Transacción	Factura
Notificación	Comunicación	Confirmación
Auditoría	Quién/cuándo	LOG-...

Regla: PERSONA ≠ SOLICITUD ≠ SERVICIO ≠ VISITA. Una persona puede tener muchas solicitudes y servicios.

6. Módulos funcionales

Personas: alta, identificación permanente, contacto, domicilio, familiares, preferencias, estado, historial y documentos.

Necesidades: compra, acompañamiento, compañía, tareas domésticas, comida, recados, paseo, citas, apoyo puntual y recurrencia.

Solicitudes: crear, validar, presupuestar, aceptar, rechazar, cancelar, reasignar y consultar historial.

Planificación: fechas, recurrencia, duración, franjas, tareas, requisitos, ubicación y notas.

Asignación: proveedor/profesional, disponibilidad, zona, servicio, requisitos y confirmaciones.

Visitas: inicio, fin, tareas, observaciones, incidencias y cierre.

Familia: representantes, permisos, seguimiento y notificaciones.

Profesionales: perfil, disponibilidad, servicios, zona, documentación y agenda.

Organizaciones: sedes, equipos, servicios, tarifas, usuarios y facturación.

Incidencias: prioridad, responsable, escalado, resolución y trazabilidad.

Documentos / notificaciones / pagos: partes, autorizaciones, presupuestos, comunicaciones, cobros y facturas.

Auditoría: accesos, modificaciones, exportaciones, permisos y acciones administrativas.

7. Flujos principales

Solicitar ayuda: Inicio → ¿En qué necesitas ayuda? → ¿Para quién? → Qué → Dónde → Cuándo → Duración → Preferencias → Resumen → Confirmar.

Solicitar por familiar: Familia → Persona representada → Nueva ayuda → Solicitud → Confirmación → Seguimiento.

Asignar: Solicitud → disponibilidad → proveedor/profesional → propuesta → aceptación → servicio confirmado.

Realizar visita: Agenda → servicio → iniciar → tareas → observación → incidencia opcional → finalizar.

Incidencia: Crear → clasificar → responsable → notificar → resolver/escalar → cerrar.

Reasignación: Servicio → profesional no disponible → sustituto → confirmación → notificación.

Cierre: última visita → resumen → validación → factura/pago → encuesta opcional → cierre.

Emergencias: CUIDA no debe presentarse como servicio de emergencias; debe indicar claramente que ante una emergencia se contacte con los servicios correspondientes.

8. Máquina de estados

Entidad	Estados
Solicitud	Borrador → Enviada → En revisión → Buscando → Propuesta → Aceptada → Cancelada → Cerrada
Servicio	Pendiente → Asignado → Confirmado → En curso → Finalizado → Validado → Cerrado
Visita	Programada → Confirmada → En curso → Finalizada → Incidencia → Revisada
Incidencia	Nueva → En revisión → Asignada → En resolución → Resuelta → Cerrada
Persona	Pendiente → Activa → Suspendida → Archivada
Profesional	Pendiente → Verificado → Activo → Suspendido → Inactivo
Organización	Prueba → Activa → Suspendida → Cerrada

Cada cambio debe registrar quién, cuándo, estado anterior, nuevo estado y motivo.

9. Interfaces

CUIDA PERSONAS: interfaz simple: próximo servicio, solicitar ayuda, historial, familiares y contacto.

CUIDA FAMILIA: personas a cargo, servicios, calendario, seguimiento, incidencias y documentos.

CUIDA PROFESIONAL: agenda del día, servicio, ubicación, tareas, iniciar/finalizar, observaciones e incidencias.

CUIDA ORGANIZACIÓN: dashboard, solicitudes, agenda, profesionales, personas, servicios, incidencias, documentos y facturación.

ADMIN: organizaciones, usuarios, roles, catálogo, reglas, auditoría, seguridad e integraciones.

Mobile first: persona y profesional deben resolver sus acciones esenciales desde móvil; coordinación puede optimizarse para escritorio.

10. Motor de asignación

El MVP debe realizar asignación manual. El motor automático se incorpora después.

Variables futuras: disponibilidad, distancia/zona, tipo de servicio, duración, recurrencia, requisitos, preferencias legítimas y necesarias, continuidad del profesional y reglas de organización.

No automatizar inicialmente: decisiones clínicas, diagnósticos, evaluación de dependencia o selección basada en atributos sensibles.

Salida: lista de candidatos explicable → coordinador selecciona → sistema registra resultado → profesional recibe propuesta.

11. Modelo empresarial

SaaS B2B: empresas de ayuda a domicilio pagan por gestionar servicios.

Marketplace/B2B2C: CUIDA conecta solicitudes con proveedores/profesionales y cobra comisión o tarifa de plataforma. Requiere análisis jurídico y operativo.

Híbrido: empresas pagan software y CUIDA puede gestionar servicios externos.

White label: organizaciones utilizan CUIDA con su marca.

Ingresos adicionales: módulos premium, usuarios, automatizaciones, API, analítica, comunicaciones y soporte.

Los precios iniciales deben tratarse como hipótesis y validarse con empresas. El objetivo inicial es encontrar un modelo sostenible, no fijar una tarifa definitiva.

Cliente inicial: pequeñas y medianas empresas privadas de ayuda a domicilio y asistencia personal que necesitan coordinación digital.

12. MVP

P	Función	Objetivo
P0	Registro/login	Acceso
P0	Personas	Identidad
P0	Familiares autorizados	Representación
P0	Crear solicitud	Necesidad
P0	Catálogo	Estructura
P0	Fechas/horarios	Servicio
P0	Solicitud → servicio	Operación
P0	Profesionales	Asignación
P0	Agenda	Operación
P0	Iniciar/finalizar	Ejecución
P0	Tareas + observaciones	Parte
P0	Incidencias	Control
P0	Notificaciones	Seguimiento
P0	Historial	Trazabilidad
P0	Roles/permisos	Seguridad
P1	Pagos	Monetización
P1	Documentos	Gestión
P1	Portal familiar avanzado	Transparencia
P2	Matching automático	Escala
P2	IA	Asistencia
P2	API	Integraciones
P3	White label	Escala B2B

13. Arquitectura técnica

Frontend: React + TypeScript + Vite; Tailwind si encaja con el sistema visual; responsive/mobile-first.

Backend: API, autenticación, autorización, lógica de negocio y auditoría.

Base de datos: PostgreSQL candidata para relaciones, estados y trazabilidad.

Archivos: almacenamiento de objetos para documentos/imágenes y metadatos en BD.

Notificaciones: email/push/SMS opcional desacoplados.

Jobs: recordatorios, vencimientos, sincronizaciones y alertas.

Multi-tenant: aislamiento por organización desde el principio si será SaaS.

Observabilidad: logs, métricas, errores y alertas.

Backups: copias, restauración probada y continuidad.

14. Privacidad, seguridad y marco legal

Este apartado es crítico. Si CUIDA trata datos de salud, entran en juego categorías especialmente protegidas y requisitos reforzados. La AEPD señala que su tratamiento requiere una base jurídica adecuada y garantías, y que el enfoque de riesgo debe guiar las medidas. [cite\turn0search0\turn0search12]

La seguridad debe garantizar confidencialidad, integridad y disponibilidad, con medidas técnicas y organizativas adecuadas al riesgo. [cite\turn0search9]

El RGPD exige un enfoque de responsabilidad proactiva que puede incluir registro de actividades, análisis de riesgos, evaluación de impacto cuando proceda, privacidad desde diseño y por defecto, seguridad, gestión de brechas y contratos con encargados. [cite\turn0search10\turn0search12]

La AEPD advierte que incluso un acceso no autorizado realizado por personal interno puede constituir una brecha. [cite\turn0search5]

Producto: minimización, permisos por rol/relación, sesiones seguras, MFA para perfiles sensibles, cifrado, auditoría, revocación, retención/borrado, gestión de incidentes y recuperación.

Separación: ayuda cotidiana ≠ diagnóstico sanitario. El cuidador puede registrar una observación o incidencia, pero no debe actuar como profesional sanitario.

15. Calidad y pruebas

Probar: identificación, permisos, asignación, doble reserva, cancelaciones, sustituciones, incidencias, pérdida de conexión, duplicados, errores horarios, notificaciones, exportaciones y cierre.

Casos críticos: acceso indebido; revocación de familiar; visita no iniciada; doble inicio; cancelación; cambio de horario; documento eliminado; cuenta comprometida; móvil perdido; offline.

Definition of Done: cada función debe tener validaciones, permisos, errores, auditoría cuando corresponda, pruebas y comportamiento responsive.

16. Roadmap

Fase	Contenido	Resultado
0 Investigación	Usuarios, entrevistas, competencia, legal	Hipótesis
1 Concepto	Propuesta, actores, journeys	Product brief
2 Arquitectura	Datos, roles, estados, permisos	Especificación
3 UX/UI	Wireframes + sistema visual	Prototipo
4 Core	Auth, personas, organizaciones	Base
5 Solicitudes	Necesidad → solicitud → plan	Flujo
6 Operación	Profesionales, agenda, visitas	Servicio
7 Seguimiento	Familia, alertas, incidencias	Ciclo cerrado
8 Seguridad	Auditoría, backups, hardening	Base segura
9 Piloto	Escenarios y usuarios ficticios	MVP evaluado
10 Negocio	Precios, contratos, onboarding	Modelo
11 Beta	Primeras organizaciones	Validación
12 Escala	Pagos, matching, IA, API	Producto avanzado

17. Backlog inicial

01. Definir problema, usuario primario y comprador inicial.
02. Entrevistar empresas, familiares y profesionales.
03. Analizar competencia y documentar huecos.
04. Definir 10 casos de uso.
05. Definir catálogo de necesidades.
06. Definir diferencia entre necesidad, solicitud y servicio.
07. Definir Persona e identificador CUI permanente.
08. Definir Familiar/representante.
09. Definir Profesional y Organización.
10. Definir Servicio y Visita.
11. Definir Tarea, Actuación e Incidencia.
12. Definir estados y transiciones.
13. Definir matriz de roles/permisos.
14. Diseñar journey de Herminia.
15. Wireframe de solicitud.
16. Wireframe de profesional.
17. Wireframe de familia.
18. Wireframe de coordinador.
19. Definir MVP P0.
20. Crear modelo de base de datos.
21. Crear API y autenticación.
22. Crear permisos y auditoría.
23. Crear flujo solicitud→servicio.
24. Crear agenda y visita.
25. Crear incidencias y notificaciones.
26. Crear historial.
27. Crear pruebas de seguridad.
28. Definir pricing experimental.
29. Preparar demo y Definition of Done.

18. KPIs

Métrica	Qué indica
Tiempo solicitud→servicio	Capacidad de resolver
% solicitudes cubiertas	Oferta disponible
% servicios completados	Fiabilidad
Incidencias/100 servicios	Calidad
Tiempo de resolución	Coordinación
Cancelaciones	Fricción
Repetición	Valor percibido
Tiempo administrativo ahorrado	ROI B2B
Retención de organizaciones	Valor SaaS
Satisfacción	Experiencia
Coste de soporte	Escalabilidad

19. Riesgos

Riesgo	Tratamiento
Ser solo una agenda	Centrar ciclo necesidad→servicio→seguimiento
Marketplace complejo	Empezar B2B con asignación manual
Responsabilidad laboral	Validación jurídica antes de operar
Datos sensibles	Minimización + privacidad desde diseño
Fraude/identidad	Verificación + auditoría
No-shows	Alertas + sustitución
Poca oferta	Piloto con organización real
UX compleja	Interfaces por rol
IA mal utilizada	IA administrativa + revisión humana
Costes operativos	Límites y control de consumo
Competencia	Especialización en coordinación

20. Evolución futura

CUIDA Match: sugerencia de profesionales disponibles.

CUIDA Family: coordinación familiar avanzada.

CUIDA Connect: API e integraciones.

CUIDA AI: estructuración de solicitudes, resúmenes y apoyo administrativo.

CUIDA Pay: presupuestos y pagos.

CUIDA Care Plans: planes recurrentes.

CUIDA Analytics: demanda, capacidad, calidad e incidencias.

White label: organizaciones con su marca.

Escalado: ayuda a domicilio → asistencia personal → acompañamiento → centros de día → otros servicios asistenciales, siempre con adaptación legal y funcional.

21. Portfolio

Problema: una familia necesita ayuda para una persona, pero convertir una necesidad cotidiana en un servicio fiable requiere coordinación.

Insight: la unidad fundamental no es el cuidador ni la cita; es la necesidad de la persona.

Concepto: CUIDA transforma necesidades en servicios coordinados.

Arquitectura: persona → necesidad → solicitud → servicio → visita → actuación → seguimiento.

Demo: mostrar el caso Herminia de principio a fin.

Nota: declarar que es prototipo conceptual y no introducir datos reales sensibles.

22. Conclusión estratégica

La evolución de IDENTIA a CUIDA no consiste en cambiar el nombre de una intranet. Consiste en introducir una nueva unidad de negocio: la necesidad de una persona. IDENTIA organizaba identidad y documentación; CUIDA organiza una necesidad hasta convertirla en una atención realizada.

El núcleo conceptual queda así: PERSONA → NECESIDAD → SOLICITUD → SERVICIO → VISITA → ACTUACIÓN → SEGUIMIENTO → HISTORIAL.

Si esta cadena funciona de extremo a extremo con el caso de Herminia, tendrás una base suficientemente sólida para construir después un producto más amplio.

Fuentes de referencia: Ministerio de Derechos Sociales sobre evolución de cuidados a domicilio y asistencia personal; AEPD sobre datos de salud, seguridad, acceso y responsabilidad proactiva.

`[cite[turn0search6[turn0search13[turn0search0[turn0search9[turn0search10]`

Este documento es un masterplan de producto y no constituye asesoramiento jurídico, sanitario, laboral ni de protección de datos. Antes de explotación real deben validarse las obligaciones aplicables al modelo concreto.